

Video_2026-04-28_160328_Индвиго (CRM 1 встреча)

Video_2026-04-28_160328_Индвиго (CRM 1 встреча)

Ключевые слова: Crm, Сегментация пациентов, Оплата, Customer journey map, Продажи, Маркетинг и продажи, Жизненный цикл клиента

Участники: Speaker A , Speaker C , Наталья (Speaker B) , Наташа (Speaker D)

AI отчет: Протокол

Супер краткое содержание

- Обсудили необходимость создания и заполнения Customer Journey Map (CGM) с участием отделов маркетинга, колл-центра, администраторов, врачей и отдела продаж. 0:00
- Определили, что маркетинг отвечает за этап до визита, включая каналы привлечения пациентов и точки входа. 11:00
- Уточнили, что сегментация пациентов должна учитывать первичный и повторный визит, а также разные сценарии обращения (например, на прием или обследование). 7:00
- Обсудили параметры для CRM: фиксировать источники обращения, жалобы, возраст, поведенческие факторы и сегментацию по теплоте клиента. 15:00
- Рассмотрели этапы работы с пациентом после приема: передача назначений от врача в отдел продаж, оформление заказов и контроль оплаты. 30:00
- Подчеркнули важность единовременной оплаты полного курса лечения для повышения ответственности пациента и планирования ресурсов. 54:00
- Поставили задачу Наташе подготовить регламенты работы с пациентами и стандарты продаж к 30 апреля для совместной работы с Андреем и Натальей. 44:00
- Обсудили необходимость внедрения системы напоминаний и контроля оплаты, включая возможность отправки QR-кодов для онлайн оплаты. 53:00
- Запланировали встречу 7 мая для обсуждения готовых материалов и дальнейших шагов по интеграции CRM и процессов работы с пациентами. 58:50

Протокол

Разработка и заполнение шаблона Customer Journey Map (CGM) 4:12

Контекст: Вадим предложил создать более наглядный и понятный шаблон CGM для отдела продаж, включающий все этапы взаимодействия с клиентом, начиная с маркетинга и заканчивая отделом продаж. Действия: Создать и заполнить шаблон CGM с необходимыми полями для всех подразделений, включая маркетинг, колл-центр, администраторов, врачей и отдел продаж. Ответственные: Вадим (Speaker A) и команда. Сроки: До 7 мая (следующая встреча).

Определение точек входа и каналов привлечения клиентов 6:20

Контекст: Обсуждалась необходимость объединения и контроля всех каналов привлечения клиентов (сайт, сарафанка, баннеры, колл-центр и др.) для понимания точек входа клиента. Действия: Слить все источники привлечения клиентов воедино и контролировать их. Ответственные: Маркетинговая команда. Сроки: До 7 мая (следующая встреча).

Сегментация пациентов и этапы взаимодействия с клиентом 7:08

Контекст: Обсуждались сценарии взаимодействия с пациентами на разных этапах жизненного цикла, включая первичный прием, обследования и работу отдела продаж. Действия: Определить и зафиксировать сценарии и этапы взаимодействия с пациентами, включая передачу информации между подразделениями. Ответственные: Наташа (Speaker D) и Андрей (Speaker A). Сроки: До 30 апреля (подготовить предварительные данные).

Video_2026-04-28_160328_Индвиго (CRM 1 встреча)

Фиксация и учет первичного и повторного пациента в CRM 16:43

Контекст: Обсуждалась необходимость учета в CRM как первичных, так и повторных пациентов с учетом их жизненного цикла и истории взаимодействия с клиникой. Действия: Внедрить учет первичных и повторных пациентов с возможностью отслеживания истории и сегментации по времени и активности. Ответственные: Вадим (Speaker A) и команда CRM. Сроки: До 7 мая (следующая встреча).

Определение метрик и отчетов для анализа клиентской базы 22:00

Контекст: Наталья и Вадим обсудили необходимость определения метрик (средний чек, LTV и др.) и отчетов для анализа клиентской базы и эффективности работы с клиентами. Действия: Определить и зафиксировать необходимые метрики и отчеты для анализа клиентской базы и работы отдела продаж. Ответственные: Наталья (Speaker B), Вадим (Speaker A) и команда аналитики. Сроки: До 30 апреля (предварительные данные).

Разработка системы напоминаний и коммуникаций с пациентами до визита 27:15

Контекст: Обсуждалась необходимость создания системы напоминаний пациентам о подготовке к визиту, оплате и изменении записи через звонки, СМС и мессенджеры. Действия: Разработать систему напоминаний и коммуникаций с пациентами, включая звонки, СМС и мессенджеры, с возможностью изменения записи. Ответственные: Колл-центр и IT-команда. Сроки: До 7 мая (следующая встреча).

Внедрение электронного оформления заказов и консультативных листов 34:44

Контекст: Обсуждалась необходимость предзаполнения заказов врачами в электронном виде для упрощения передачи информации в отдел продаж и повышения точности данных. Действия: Внедрить систему электронного оформления заказов и консультативных листов с возможностью передачи данных в отдел продаж. Ответственные: Врачи, IT-команда и отдел продаж. Сроки: В процессе, контроль до 7 мая.

Установление стандартов и регламентов для врачей и отдела продаж 36:19

Контекст: Обсуждалась необходимость разработки стандартов и регламентов для врачей по заполнению консультативных листов и для отдела продаж по работе с клиентами. Действия: Разработать и внедрить стандарты и регламенты для врачей и отдела продаж, включая правила исправлений и контроля данных. Ответственные: Главный врач, Наташа (Speaker D) и Вадим (Speaker A). Сроки: До 30 апреля (подготовить регламенты).

Внедрение системы сегментации клиентов по возрасту и поведенческим факторам 24:16

Контекст: Обсуждалась возможность автоматического присвоения статусов клиентам по возрасту и поведенческим факторам для улучшения работы менеджеров отдела продаж. Действия: Внедрить систему сегментации клиентов по возрасту и поведенческим факторам с подсказками для менеджеров. Ответственные: Вадим (Speaker A) и IT-команда. Сроки: После запуска базовой версии CRM, сроки уточнить.

Внедрение функционала контроля оплаты и стадий сделок в CRM 57:00

Контекст: Наташа обозначила необходимость контроля этапности оплаты услуг пациентами и возможности видеть суммы частично и полностью оплаченных сделок для управления задачами менеджеров. Действия: Разработать функционал в CRM для контроля оплаты, стадий сделок и автоматического создания задач для менеджеров по просроченным платежам. Ответственные: Наташа (Speaker D), Вадим (Speaker A) и IT-команда. Сроки: До 7 мая (следующая встреча).

Организация встречи для обсуждения регламентов и текущих процессов 46:59

Контекст: Обсуждалась необходимость встречи 30 апреля для совместного обсуждения регламентов, стандартов и текущих процессов с участием Наташи, Вадима и Андрея. Действия: Провести встречу 30 апреля с 12:00 до 17:00 для обсуждения регламентов и текущих процессов. Ответственные: Наташа (Speaker D), Вадим (Speaker A), Андрей (Speaker C). Сроки: 30 апреля, с 12:00 до 17:00.

Передача задач по заполнению данных маркетинга Владу Гусельникову 59:22

Video_2026-04-28_160328_Индвиго (CRM 1 стреча)

Контекст: Вадим сообщил, что передаст задачи по заполнению данных маркетинга Владу Гусельникову после его выхода из отпуска для дальнейшей работы под контролем Вадима. Действия: Передать задачи по заполнению данных маркетинга Владу Гусельникову и контролировать выполнение. Ответственные: Вадим (Speaker A), Влад Гусельников. Сроки: После выхода Влада из отпуска (примерно после 7 мая).

Задачи

- ☐ Исправить сегментацию пациента в Customer Journey Map и предоставить доступ для редактирования Наталье (Исполнитель: Наталья (Speaker B))
- ☐ Добавить гугловскую почту в Teams для автоматического подхвата данных (Исполнитель: Speaker A)
- ☐ Создать и отправить шаблон таблицы для заполнения полей CGM отделом продаж и маркетингом с учетом всех этапов жизненного цикла клиента (Исполнитель: Speaker A)
- ☐ Объединить и контролировать все источники точек входа клиентов (сайт, сарафанка, баннеры и др.) в единую систему (Исполнитель: Наталья (Speaker B))
- ☐ Определить и четко описать сценарии сегментации пациентов, включая случаи первичного приема, обследования и взаимодействия с ЦОЗ и отделом продаж (Исполнитель: Наташа (Speaker D))
- ☐ Организовать передачу информации о пациентах с диагностикой из ЦОЗ в отдел продаж с напоминаниями и точками контакта (Исполнитель: Speaker A)
- ☐ Прорисовать пути клиента от источника обращения до этапа до визита, включая каналы маркетинга и колл-центр (Исполнитель: Speaker A , Срок: 07.05)
- ☐ Подготовить материал по метрикам и отчетам (средний чек, LTV и др.) для обсуждения на встрече 8 мая (Исполнитель: Наталья (Speaker B) , Срок: 07.05)
- ☐ Определить параметры и уровни сегментации пациентов для CRM, включая первичный и повторный контакт, жалобы и направления (Исполнитель: Speaker A)
- ☐ Обсудить и определить, как учитывать возраст и поведенческие факторы пациентов для сегментации и аналитики в CRM (Исполнитель: Наташа (Speaker D))
- ☐ Разработать и внедрить систему напоминаний пациентам перед визитом (звонки, смс, мессенджеры) с возможностью отмены или переноса записи (Исполнитель: Speaker A)
- ☐ Рассмотреть возможность предоставления врачам готовых анализов и обследований пациентов до приема для сокращения времени консультации (Исполнитель: Наташа (Speaker D))
- ☐ Зафиксировать и описать процесс работы с документами пациента, включая верификацию через МАКС и хранение данных, а также определить, какие данные и действия пациента необходимо фиксировать для перехода на следующие этапы (Исполнитель: Наталья (Speaker B))
- ☐ Доработать систему предзаполнения заказов на основе консультативных листов в электронном виде и организовать работу с врачами для внедрения этой функции (Исполнитель: Наталья (Speaker B))
- ☐ Согласовать и внедрить стандарты заполнения консультативных листов с главным врачом, исключая возможность внесения несанкционированных изменений и обеспечив соответствие Минздраву (Исполнитель: Наталья (Speaker B))
- ☐ Настроить CRM для автоматического отслеживания назначений врача, включая сроки прохождения обследований и планирование контактов отдела продаж через 3 дня после первичного приема (Исполнитель: Наталья (Speaker B))
- ☐ Разработать и внедрить в CRM функционал сегментации клиентов по степени готовности к покупке и этапам оплаты, включая отображение суммы выкупа и частичной оплаты, а также контроль этапности сделок и напоминания о просрочках (Исполнитель: Наташа (Speaker D))
- ☐ Организовать возможность отправки QR-кодов для онлайн оплаты пациентам, в том числе иногородним, для ускорения процесса оплаты и планирования лечения (Исполнитель: Наташа (Speaker D))
- ☐ Подготовить и описать регламенты работы с пациентами и стандартные сценарии продаж, включая отработку возражений, для передачи Андрею и дальнейшего обсуждения (Исполнитель: Наташа (Speaker D) , Срок: 30.04.24)
- ☐ Провести встречу с Андреем 30 апреля с 12:00 до 17:00 для обсуждения регламентов, комментариев и доработок CRM с участием Наташи и Натальи (Исполнитель: Наталья (Speaker B) , Срок: 30.04.24)
- ☐ Обеспечить контроль и анализ неоплаченных процедур и сделок в CRM с возможностью постановки задач менеджерам для обзвона клиентов и повышения оплаты (Исполнитель: Наташа (Speaker D))
- ☐ Провести встречу с маркетингом после 12:00 в четверг для обсуждения данных и интеграции с CRM, подготовить необходимые материалы для передачи Владу Гусельникову под контролем Speaker A (Исполнитель: Наталья (Speaker B) , Срок: 07.05.24)

Транскрипт

1. Обсуждение структуры Customer Journey Map и сегментации пациентов

0:00:00 Наталья (Speaker B): Сейчас давай открою со второй вкладки. Так. А ты мне отправил его где? В чате?

0:00:18 Наташа (Speaker D): Да, в этом, в Тимсе. Ну, в личку скинула. Тебе же скинула?

0:00:24 Speaker C: Да. CGM.

0:00:35 Наталья (Speaker B): Это мне надо открыть в другой вкладке. Ага, открывается. Давай попробую сейчас. Тут только так можно, да? Вы что сейчас видите? Customer Journey Map или архив?

0:01:34 Наташа (Speaker D): Архив!

0:01:40 Speaker C: Сейчас, сюда перейдем. Угу.

0:01:49 Наташа (Speaker D): Но я бы все-таки со второй вкладки начала. Это третья, да, у нас. Так, не вопрос. Вкладка номер два. Эта табличка, она мне не очень, если честно. Ну, как бы она для меня менее понятна.

0:02:01 Наталья (Speaker B): Ну, тут, видишь, у тебя сегментация пациента обновленная. Да, да, да, да. Ага, да, я сразу поправлю. А, у меня нету прав на результирование. Андрюша.

0:02:23 Speaker A: Андрей, а помнишь, как-то на Google Почту...

0:02:42 Наташа (Speaker D): Всё, открыла. Должно быть всё.

0:02:48 Speaker A: Так, папки я полностью стираю. Так, аккаунты. А, у тебя же нет. Просто потом в Teams добавь гугловскую почту, чтобы оттуда подхватывать.

0:02:58 Наталья (Speaker B): Это же мой личняк совсем. Это же мой личняк вообще. ну так а как доступа тебе давать ладно хорошо я добавлю ну так вот скидываю алексею наталья тебе ну мне хотя бы откинь чтобы я закрепил где-то с тобой сейчас давай я тебе отдельно откинул отправил итак вкладка давай сейчас сразу чтоб я понял

0:03:31 Наташа (Speaker D): Ты тогда можешь для себя какие-то это я для себя как тебе будет удобней там сделать что хочешь вкладка 2

0:03:50 Наталья (Speaker B): Записан, пришел, прием проведен, врач, куратор. Непонятно, конечно. Ну, точки входа. Ну, вот теперь да, будем. Да, точки входа нужно понимать. Что такое точки входа? Ну, это сайт, это обманок, это ножка не зашел.

2. Распределение ролей и этапов взаимодействия с пациентом до визита

0:04:12 Speaker A: Давай я тебе скину, что мы только за 10 минут искреснули, что у нас получилось. Я сделал быстро очень шаблон, но он еще не актуально заполнен. Мы с тобой уже можем распланировать поля, которые нужно будет заполнить всем участникам. Мне кажется, так будет вернее. Так, я тебе отправлю. который, мне кажется, будет нагляднее заполнять.

0:04:43 Speaker C: Сейчас откроется.

0:04:53 Speaker A: И мы сейчас просто нанизим туда те поля дополнительные, которые нам нужны. Если мы говорим там о довизита, то есть мы можем прям накидать прям адрес, вставить строки, столбцы, которые нужно заполнить будут. Мне кажется, что эта таблица более наглядная и понятная. Смотри, мы, как с Натальей сейчас пока смотрели, мы хотели заполнить CGM именно пока отдела продаж. Но вот сейчас начинаю с тобой разговаривать, да, да, только отдел продаж. Но я понимаю, что если в целом посмотреть на сервер, то нужно с маркетингом. Как раз-таки сайт, каналы, прочее, колл-центр, потом идут администраторы, потом идут у нас врачи, и только потом отдел продаж только на пятом этапе. То есть, по сути, если сейчас посмотришь на слобец А, то отдел продаж включается только на третьем этапе. Это продажа. А все, что идет до него, это еще три подразделения. Сейчас подчеркну. Если нужны комментарии, это очень быстрый промп того, что у нас происходит, и очень простой шаблон. Я могу прокомментировать то, что происходит на первом этапе, чтобы у всех было общее понимание, или можно было правки уже сейчас общие ввести.

0:06:20 Speaker A: До визита происходит все то, что касается поиска пациентам информации, то, где он на нее натывается и как он записывается. То есть все это максимум опирается в SOS.

0:06:35 Наталья (Speaker B): С целого и сарафанка.

Video_2026-04-28_160328_Индвиго (CRM 1 встреча)

0:06:38 **Speaker A:** Там все каналы, по сути, там должны быть все маркетинговые каналы, сарафан, рекомендация, с улицы зашел, все что угодно.

0:06:46 **Наталья (Speaker B):** Увидел баннер, либо растяжка, вот эти все. Тут как раз нужно слить все вот эти источники воедино, то есть их контролировать.

0:06:56 **Speaker A:** Андрей, скажи, чтобы было понятно, куда заполнить это. Потому что это будет портянка, у нас порядка 30, наверное, каналов.

0:07:02 **Наталья (Speaker B):** Да вот здесь же и заполняй.

0:07:05 **Speaker A:** Прямо вот в этой ячейке.

0:07:08 **Наташа (Speaker D):** Вадим, вот сразу вопрос можно? Да. Вот то, что у нас идет первичный прием, это же может быть, он сначала может к нам прийти на прием и на обследование. Это будем как-то учитывать или нет?

0:07:28 **Наталья (Speaker B):** Это уже сегменты дальнейшие или как, Вадим?

0:07:31 **Speaker A:** Это сегментация пациентов.

0:07:33 **Наташа (Speaker D):** Это у меня...

0:07:36 **Speaker A:** По сути, это один и тот же жизнь цикла клиента, просто он зашел к нам в центр на разных этапах.

0:07:45 **Наташа (Speaker D):** Просто в отдел продаж он заходит на приеме только, но он может попасть в центр без приема, на УЗИ. Это не ко мне же идет, получается.

0:07:54 **Speaker A:** Но так или иначе в CGM он присутствовать будет.

0:07:57 **Наташа (Speaker D):** Я и говорю, на каком этапе это будет.

0:07:59 **Speaker A:** Что на каком этапе это будет?

0:08:00 **Наташа (Speaker D):** Вот эта сегментация, он пришел на прием, либо он пришел на этот...

0:08:05 **Speaker A:** Вот это нужно Андрею сказать. Это не Андрей должен будет придумать, это должны придумать те, кто с этим работает. То есть ты должна сказать сейчас, как вот этот кейс возник, да, он пришел человек на УЗИ к нам. И ты должна Андрею дать задачу. Андрей, ко мне пришел человек, не ко мне на первичный период, мой куратор его не поймал, но он пришел на УЗИ.

0:08:25 **Наташа (Speaker D):** Но это тогда не я делаю, это делают админы.

0:08:28 **Speaker A:** Нет, Роташ. Это твоя задача. Ты должен Андрею сказать, Андрей, мне нужен этот пациент, потому что пройдя диагностику, у него заключение. отдел продаж с ним будут работать. То есть у тебя должна выскочить точка контакта с этим человеком. Здравствуйте, институт движения, вы были у нас на диагностике, на МРТ суставов, вам показано прием травматолога-ортопеда. И Андрей тебе должен создать такую инфраструктуру, которая в твой отдел продаж отправит эту информацию, даст напоминание.

0:09:05 **Наташа (Speaker D):** А если там уже занесены услуги ЦОЗом?

0:09:08 **Speaker A:** Какие, например? Как он попал в ЦОЗ? Давай пофантазируем.

0:09:11 **Наташа (Speaker D):** Ну, он звонил в ЦОЗ, записался на МРТ, его записали на прием, он пришел и он сказал, я буду делать там еще 10 УВТ, и сейчас в ЦОЗ отомносят.

0:09:21 **Speaker A:** Значит, в Сиренке должно было отразиться, что этот контакт сделал в ЦОЗ, и ты... Такое может быть, если, например, клиент, он был на УЗИ, у него есть показания на прием, но его как-то пропустили на первом этаже, и он ушел домой. Он потом звонит в ЦОС снова и говорит, слушайте, а у меня в консультивной лице написано, что прием травматолога-ортопеда, можно меня записать? И ЦОС его записывает, сменяя отдел продаж. И тогда все рынки должны будут отразиться, что с ним вышел на этом учительном цикле, на этом этапе ЦОС, на контакт он его записал, и ты его уже подхватываешь после приема.

0:09:57 **Наташа (Speaker D):** Нет, подожди, если у него внесены услуги уже, он выходит с приема, у него услуги внесены, его должен вести ЦОС.

0:10:05 **Наталья (Speaker B):** Почему?

0:10:05 **Наташа (Speaker D):** Ну, потому что сейчас, давайте так, потому что ЦОС зарабатывает также с продаж. У нас на фоне чего сейчас возникают конфликты? То, что они расписывают, если раньше они вносили одну услугу, сейчас они вносят 5 или 10 массажей, PRP, там еще чего-то. И таких пациентов ЦОС сам расписывает, а не отдел продаж.

Video_2026-04-28_160328_Индвиго (CRM 1 стреча)

0:10:24 **Speaker A:** Ты мешаешь. Клиент откуда вышел?

0:10:27 **Наташа (Speaker D):** Приема он вышел.

0:10:29 **Speaker A:** Кто с ним должен работать в следующем этапе?

0:10:33 **Наташа (Speaker D):** По единственным должен работать куратор.

0:10:35 **Speaker A:** Если куратор не отработал, значит он его пропустил? Почему он его пропустил? Если он его пропустил, в 1С не попали его назначения?

0:10:45 **Наташа (Speaker D):** Они были внесены до... Кем?

0:10:47 **Speaker A:** СОЗом. Как они могут быть внесены, если он после приема должен попасть в отдел продаж?

0:10:53 **Наталя (Speaker B):** Что за он еще не попал?

0:10:54 **Speaker A:** Он не попал.

0:10:55 **Наташа (Speaker D):** Он позвонил. Вадим, вот у нас мы сейчас живем в таком, у нас есть уже эти ситуации. Я пациент. Я, например, сходила к своему терапевту, мне назначили массаж. Я звоню и говорю, ну, к примеру.

0:11:07 **Speaker A:** Я же задал вопрос, откуда он ушел, ты говоришь, с приема. А сейчас ты дорисовываешь, что он с какого-то другого. Ты мешаешь все в одну кучу. Понимаешь, тебе Андрей про эту сегментацию и говорит, что нужно четко нарисовать каждый сценарий, как это работает. А ты сейчас пытаешься все схлопнуть вокруг какой-то конкретной проблемы ЦОЗа и отдела продаж.

0:11:28 **Наташа (Speaker D):** Я предусматриваю все варианты.

0:11:31 **Наталя (Speaker B):** Я отмечаю вот эти проблемы, это хорошо, что их предусматриваю. Но сейчас мы еще до них не добрались. То есть сначала каждый путь клиента, вообще откуда он пришел, как он движется, это отдельно прорисовать надо. Поэтому вот здесь вот откуда обращается перечислить каналы, точка контакта, то есть вот это вот до визита, по сути вот этот столбик мне его нужно нарисовать.

0:11:55 **Наташа (Speaker D):** Его кто должен рисовать? Тоже я?

0:11:57 **Наталя (Speaker B):** Ну, можешь поручить кому-то из своих девочек.

0:12:00 **Speaker A:** Нет, это маркетинг идет рисовать.

0:12:03 **Наталя (Speaker B):** То есть продажи тут еще пока не знают, да?

0:12:06 **Speaker A:** Тут они не начинаются, они тут не знают, они еще не встретились вообще с продажами, но тут уже маркетинг организывает те самые каналы, через которых он пытается на них выходить, на клиентов потенциальных. Возможно, чуть-чуть колл-центра мы сюда добавим, потому что... почему записываются. Это, знаешь, такая будет качественная фактура больше.

0:12:34 **Наталя (Speaker B):** Так, от соуса ты что-то написал тут? Это колл-центр. Ну, я к тому, что... Это колл-центр, а ты к чему?

0:12:40 **Speaker A:** Ну, я написал колл-центр, потому что, по сути, это единственный на вот этом первом этапе до визита, ну, на любом этапе, это единственная структура, которая касается с клиентом. То есть маркетинг организовал канал, рекламную кампанию запустил, но он не соприкоснулся, он не пообщался с клиентом, он просто на него информацию дал. Происходит исходящий звонок или чат, все, колл-центр начинает с ним работать. Источник ряда, жалобы и так далее, это все как бы колл-центр продолжает с ним общаться, выявляет потребность, услугу, куда он записывает клиента. И как бы для задачи менеджера тут не отдел продаж, а опять же СОС, он совершает запись на звонке, и за день до визита напоминает. То есть, по сути, единственная живая структура, как касается клиентов, здесь как в центре.

0:13:26 **Наталя (Speaker B):** Так, у нас вот столбик задачи менеджера, это подразумевается расширенно. Тут может быть и администратор, тут может быть и сотрудник СОЗа, тут может быть и куратор. Последний столбик я сейчас отмечаю, с кого я буду спрашивать эту информацию. Отлично. Еще вот так вот сделаем.

0:14:01 **Speaker A:** Андрей, еще вот так. Сразу же. Так, на маркетинг Влад в отпуске, но я думаю, что... Где-то до 8-го, да? Попробуем до 8-го.

0:14:15 **Наталя (Speaker B):** Я не помню, когда там лад выходит. Тогда 7-го оставим. То есть 8-го у нас встреча, поэтому чтобы к встречам мы не пустые пришли, 7-го мая готовить материал.

0:14:31 **Speaker A:** Так, смотри, Андрей, давай еще раз. какие-то металлина нужно .

0:14:38 **Наталя (Speaker B):** Ну слушай вот эти вот b и c для меня они очень одинаковые то есть действие пациента как он пришел к нам и через что он пришел то есть по идее с это вот конкретное наименование через что он обращается потому что у нас по факту сейчас вроде

Video_2026-04-28_160328_Индвиго (CRM 1 встреча)

ощутимо что это только звонок и чат и Прямой визит есть еще. Прямой визит, но все равно сарафанку никто никогда не оценил. Мы ее отслеживаем и отслеживаем. То есть вот эти рекомендации, опять же, порекомендуете друзьям, знакомые прислали сюда. Пока нет. И многоточие.

0:15:30 **Speaker A:** Давай, D2. Источник ряда, жалоба, отжимаемая дата визита, как вы говорите.

0:15:36 **Наталья (Speaker B):** Я тут не придумаю. То есть это хороший столбец информации, которую CRM должна фиксировать, и это здесь полностью, я ожидаю от вас.

0:15:46 **Speaker A:** Тоже.

0:15:46 **Наталья (Speaker B):** То есть что фиксируем на звонке, по сути? Тут вопрос сразу же, вот эту сегментацию первичную уже проводить тут или нет? Сколько уровней сегментации вообще в принципе планируется? То есть собираемся мы сегментировать их, откуда пришел, как пришел, какие у него там жалобы, направления. То есть каждый вот этот слой нужно... Его можно, но...

0:16:10 **Speaker A:** Как это может быть реализовано? То есть, по сути, для того, чтобы заполнить эти поля, оператору нужно спросить этого пациента.

0:16:18 **Наталья (Speaker B):** Возможно спросить, но на самом деле, на текущий момент, с учетом того, что у нас есть телефония, есть сайты и есть социальные сети, больше из этих частей можно подтянуть к рекламе определенными.

0:16:36 **Speaker A:** По принципу сквозной аналитики.

0:16:40 **Наталья (Speaker B):** По сути, да.

3. Учет повторных пациентов, LTV и аналитика жизненного цикла клиента

0:16:43 **Наташа (Speaker D):** А здесь мы будем учитывать первичный и повторный пациент или нет? Или это дальше пойдет у нас сегментация?

0:16:49 **Наталья (Speaker B):** Это всегда должно везде учитываться. То есть у нас в том числе и повторный клиент, он все равно может прийти с нуля вообще абсолютно.

0:16:59 **Speaker A:** Смотрите, я сейчас смотрю нашу CGM, именно, знаете, максимально полную. Я подозреваю, что вот этот нулевой этап, это когда у нас клиент абсолютно первичный. Если мы говорим о повторном контакте, то он просто получается, знаешь, типа накопительный.

0:17:15 **Наташа (Speaker D):** Я про то, что, смотри, будем ли мы считать повторным пациента, который не был у нас, например, 2 или 3 года, или он будет уже первичный заново? Но он у нас есть в базе.

0:17:27 **Speaker A:** Смотри, для жизненного цикла клиента в клинике он не будет первичным. Но для того, чтобы организовать ему новое комплексное лечение, новую сделку завести, потому что прошло два месяца, его назначения уже нерелевантны, состояние здоровья поменялось, врач на него смотрит, как на нового пациента. С нуля смотрит, осматривает, раздевает и так далее. Поэтому внутри CGM он не новый. Он где-то посерединке, наверное, находится, потому что он уже какой-то курс лечения прошел, либо еще что-то. Или там два года назад был, значит, мы с ним уже знакомы. А для тебя, как для новой сделки, это будет первичная история абсолютно.

0:18:02 **Наталья (Speaker B):** Мне так, ну, по-первых, кажется. Как мы потом LTV будем по ним считать?

0:18:08 **Speaker A:** По кому? От первой точки контакта, ну, LTV считается как, LTV что это? Это деньги, принесенные за весь жизнь цикла клиентов с компанией, в компании. То есть, грубо говоря, это период от первой даты обращения, то есть первичного его контакта, будь то анализа, УЗИ, МРТ или прием, который нам наиболее интересен, До сегодняшнего дня.

0:18:30 **Наталья (Speaker B):** Просто первичный прием обычно в эту сумму не идет, а идут как раз все вторичные посещения.

0:18:35 **Speaker A:** Да, на первый взгляд, да, ты прав. Может быть, первичный визит не должен входить. Но с другой стороны, если посмотреть по прямому, это все деньги, которые он оставил у нас. Как будто все чеки за время его соприкосновения с нами.

0:18:50 **Наталья (Speaker B):** И если мы просто для отдела продаж, каждый из этих продаж будет первичный, то есть сможем ли мы правильно потом продумать, отдельно посидеть и подумать, Наталья, либо тебе, либо кому-то еще?

0:19:05 **Speaker A:** Ну да, Наташа, ты можешь понимать, тебе что с точки зрения аналитики интересно, тебе интересно, какая средняя сумма сделок, Тебе важно, сколько клиент принес за последний курс лечения? Тогда что такое курс лечения? Андрей должен это влечь в какую-то границу. Или тебе важно понимать, сколько денег он всего принес? Вообще ЛТВ – это один из базовых показателей.

Video_2026-04-28_160328_Индвиго (CRM 1 стреча)

0:19:26 **Наташа (Speaker D):** Я почему слушаю? Мне больше сейчас не про деньги даже, а про то, что мы же будем потом еще дальше, когда спустимся. Почему я задаю этот вопрос сейчас? Мы же будем работать с базой. Для меня это как реанимированные пациенты, которых мы вернули. Но он может реанимироваться сам и прийти с улицы через какое-то время. Либо он будет реанимирован отделом продаж. И тут я тоже хочу это понимать.

0:19:49 **Speaker A:** Наташа, а ответить на это через LTV? Зачем тебе база через LTV? Если посмотреть на через LTV? Понимаешь вопрос? Угу. Это все деньги, которые принес клиент за всю жизнь.

0:20:07 **Наташа (Speaker D):** Мне бы, наверное, было интересно отслеживать динамику, сколько он оставил у нас. Если он у нас был в 2018 году, прошел у нас какое-то обследование и пропал, и вернулся только в 2026. Честно, неинтересно, сколько он оставил у нас в 2018. Мне будет интересно, сколько он оставил у нас сейчас и как он будет дальше с нами сотрудничать.

0:20:32 **Speaker A:** Ну, не совсем, Наташа. На самом деле, если посмотреть на это через LTV-работу с базой, то у тебя в продаже должен быть какой-то норматив. Тебе важно, чтобы средний LTV был, например, 60 тысяч рублей. И ты можешь определенным образом сегментировать клиентов и выделять тех, кто принес тебе гипермало. Например, 15 тысяч рублей. Или ты будешь понимать, что сегмент между 10 тысячами рублей или каким-то набором услуг и 30 тысяч рублей – это потенциал для продать на что-то еще.

0:21:05 **Наташа (Speaker D):** Но мы же опять говорим про весь жизненный цикл пациента.

0:21:08 **Speaker A:** Да, LTV и весь жизненный цикл.

0:21:11 **Наташа (Speaker D):** Но опять, смотри, если операции мы не будем рассматривать срок, вот этот человек, который у нас 2000, например, он был в 2018 и 26, оставил у нас, ну, грубо говоря, у него такой жизненный цикл будет 15, а кто-то пришел за один раз и оставил 60.

0:21:25 **Speaker A:** Значит, для тебя это будет сигналом к тому, что потенциал клиента большой, то есть ему должен присудиться либо какой-то сегмент другой, либо что-то еще. То есть вообще весь принцип работы CRM – это вот эта сегментация и статусы по клиентам, и потом задачи, которые будут туда накидываться, на эти сегменты и так далее.

0:21:44 **Наташа (Speaker D):** Я не против, я про то, что я хочу видеть, за какой промежуток времени он принес вот это вот.

0:21:50 **Speaker A:** Вот эти хотелки Андрей хочет услышать. И нужно понять, для чего они, потому что потом Андрей будет какой-то монитор, продаж, аналитику на этом пытаться строить или что-то.

0:21:58 **Наталя (Speaker B):** А, да.

4. Формирование метрик, задач и отчетности для отдела продаж и маркетинга

0:22:00 **Speaker A:** Двигай нас дальше, пока мы в АТО.

0:22:02 **Наталя (Speaker B):** Вообще, по-хорошему, мы просто так строим эту воронку, не для того, чтобы красиво ее выглядеть, а для того, чтобы в дальнейшем работать с ними. И, соответственно, я последний столбик сейчас действительно еще добавил, в каких отчетах понадобится. Вообще, какие метрики, что мы собираемся собирать, что мы будем смотреть. Исходя из этого, будет проще потом понять, какие действия, какие данные записывать. и как их фиксировать, что есть первичная продажа, что вторичная продажа вот это кто-нибудь не может заполнить?

0:22:44 **Наташа (Speaker D):** Наташ, забирай не понимаю пока

0:22:50 **Наталя (Speaker B):** Еще раз, Андрей, поговори. Смотри, Наташ, мы всю дальнейшую базу пациентов, кастомеров наших, собираемся каким-то образом прорабатывать. Чтобы мы по ним прорабатывали, мы должны видеть точки проседания, точки роста, точки воздействия. Эти точки мы сможем видеть и получать, исходя из каких-то метрик, отчетов, которые будет строить программа. Вот эти отчеты, какие ты собираешься делать? То есть это средний чек, LTV, у нас условно какие-то... Я про сами отчеты, то, что ты говоришь, я поняла.

0:23:38 **Speaker A:** Нужны параметры, на основании которых ты будешь проводить управленческие решения.

0:23:43 **Наташа (Speaker D):** Я чуть-чуть не понимаю, сейчас мы находимся в коммерческом маркетинге, на том этапе, когда у нас... Мы будем видеть, откуда люди приходят. И вот этот столбик, я правильно понимаю, что вот эта информация, которую мы получаем здесь, где она еще может понадобиться?

0:24:00 **Наталя (Speaker B):** Ну да, какие мы метрики должны зафиксировать на этапе 0 до визита, для того, чтобы, соответственно, ты и отдел продаж могли их прорабатывать и понимать, как можно клиентов двигать.

0:24:16 **Speaker A:** Например, Наташа рассказывает, и много родней. А, например, возраст. Возраст важен?

Video_2026-04-28_160328_Индвиго (CRM 1 стреча)

0:24:25 **Наташа (Speaker D):** Да.

0:24:26 **Speaker A:** 60 лет бабуля приехала из Сыктывкара, просто в 5 километрах от этого живет. Она будет самая теплая. Или молодой человек из Усинска, который на хрен тебе ничего не оставит.

0:24:39 **Наташа (Speaker D):** Не факт, конечно.

0:24:41 **Speaker A:** А помнишь поведенческие факторы, которые мы разрабатывали? Мы же уже обсуждали, что на этапе какого-то первичного контакта можно что-то заполнять и какие-то категории расставлять. Это сюда же, может быть.

0:24:55 **Наташа (Speaker D):** Это по поколению.

0:24:57 **Speaker A:** По поколению. Конечно, тут вопрос сейчас, наверное, по колл-центру мы это не сделаем.

0:25:01 **Наташа (Speaker D):** Нет, если там будет забираться... Андрей, скажи, если там будет... Он же знает вот эту систему про поколение, то что мы там... Он, по-моему... Мы не обсуждали. Просто если там будет подтягиваться возраст пациента, он сразу может присвоить ему определенный статус.

0:25:19 **Speaker A:** Вот третья про это и спрашивает. Нужна преаналитика, которая, понятно, на звонке, например, дойдя до менеджера, до первого контакта с каждым делом продаж, уже имеет какие-то статусы. То есть менеджер уже может понимать, что с ним делать. Иногородняя от Плюсовской. Будет понятно, что он, скорее всего, на блокадке только залетит и уедет.

0:25:44 **Наташа (Speaker D):** Я говорил про пациентов. Мы его заводим как первичный, но по факту, что он у нас уже когда-то был.

0:25:52 **Speaker A:** Так, Наташа, я предлагаю написать это четко. Параметры для ОП. фантазирует, как ты будешь с ними работать.

0:26:18 **Наташа (Speaker D):** Ох, я-то вам нафантазирую.

0:26:20 **Speaker A:** А потом скажешь. Нет, я буду готов услышать не просто фантазию, а мне нужно вот это, вот это, потому что я вот так помню с ним работать. Если мы понимаем, что действительно это нужно, мы Андрея кошмарим этим. Потому что если мы сейчас Андрея просто фантазии набросаем, он будет два года писать.

0:26:35 **Наталья (Speaker B):** Нет, смотри, вы можете фантазии фиксировать, просто я их потом скажу, что, как бы, ребят, ну... Либо преобразует, либо скажет, что это нереально.

0:26:49 **Speaker A:** Так, пока здесь окей.

0:26:52 **Наташа (Speaker D):** Можно я для себя здесь желтеньким сделаю, что я это должна делать, ладно?

0:26:57 **Speaker A:** Пожалуйста, как угодно. Смотри, Андрей, если дальше, следующий столбец, E2, этот этап касается напоминаний, то есть он не первый контакт, он контакт уже непосредственно перед визитом, колл-центр напоминает. Он дозванивает, мы готовим вот эти чаты наши.

0:27:15 **Наталья (Speaker B):** Это вот оно. Ты очень узко начинаешь сейчас смотреть, то есть про напоминания, про это, да. У нас же до визита это же не только вот эти напоминания и прочее. Тут очень много различных вариантов может быть.

0:27:27 **Speaker A:** Например?

0:27:30 **Наташа (Speaker D):** Если это анализы, напомните о том, о подготовке мы будем напоминать.

0:27:34 **Speaker A:** Это на этапе записи. Ну, кстати, Наташа, ты, наверное, права. Вообще было бы офигенно, если бы за сутки улетела подготовка, или за два дня. В мессенджер или в ВК, что мы сейчас готовим. Потому что стоматологи, например, сейчас делают офигенную перечистку, и они памятку отправляют.

0:27:53 **Наталья (Speaker B):** Слушай, я не знаю, у меня в голове такое ощущение, что здесь много всякого может быть.

0:28:00 **Speaker A:** Андрей, может, давай вместе накидаем, потому что, может быть, ты еще с точки зрения возможностей нам что-то подскажешь. Мы-то немножко деформированы тем, что у нас это нельзя, это нельзя, это не работает, это просто фантазия.

0:28:11 **Наташа (Speaker D):** А вопрос такой, а если, например, ему не звонком, а там какой-то смс-ка приходит, то, что напоминаем, а он хочет отменить эту запись, либо перенести ее, но без звонка он может это сделать или нет?

0:28:27 **Speaker A:** Ну, теоретически, наверное, возможно, но чаще всего это все равно вводится на звонок, потому что он же должен выбрать новое время, то есть его нужно перезаписать, чтобы не потерять. Поэтому там, скорее всего, обратно. Ну, или в мессенджер, если это будет возможно с чатами. Раньше это возможно было через просто позвонить, нажмим один, чтобы связаться с колл-центром и связываться.

Video_2026-04-28_160328_Индвиго (CRM 1 стреча)

0:28:53 **Speaker C:** А перед... А, ну ладно. Нет, думай, думай. Говори, что у тебя есть.

0:28:59 **Наташа (Speaker D):** Ну, варианты перед приемом. Если вести еще такую систему, то что оно это... Короче, не знаю, вы там подумайте. Когда у них есть уже на руках готовые анализы либо обследования, предоставить их врачу до приема, до прихода.

0:29:14 **Наталья (Speaker B):** Да, все верно. Ну, это жестко. Ну, это жестко, но тем не менее можно попробовать. Хотелка хорошая.

0:29:26 **Наташа (Speaker D):** Мы сможем таким образом сократить время приема, потому что либо как-то подготовить.

0:29:30 **Наталья (Speaker B):** Он сможет предоставить все равно, только непосредственно придя, потому что через телефон он не может. А эти нельзя, да? Нельзя пересылать, да? Через мессенджеры есть законы определенные. Можно предоставить, но тут вопрос, а мы как можем их обрабатывать?

0:29:50 **Speaker C:** Угу.

0:29:52 **Speaker A:** Я написал три этажного дополнения. Кажется, там может много быть разных штук. Так, на первый этап пошли. Смотри, Андрей, у нас здесь достаточно топорно написано, что происходит. Но есть здесь этап еще, например, оформление, что. Да, да, да.

5. Документы, консультативные листы и интеграция с CRM для оптимизации процессов

0:30:20 **Наталья (Speaker B):** Да, в том числе.

0:30:29 **Speaker A:** Это нужно фиксировать вообще? И если нужно, то как?

0:30:33 **Наталья (Speaker B):** Ну вот как это фиксировать в карточке? Не, не в карточке, именно здесь для тебя, ведь это важно. И перечисление всего, что вы хотели бы зафиксировать. Тут вопрос в том, мы как потом будем с этим действовать? То есть мы для каждой такой информации будем придумывать какое-то отдельное место хранения или все в кучу всыпать? Про документы сейчас говоришь?

0:30:55 **Speaker A:** Да. Но документы они сейчас заполняются. Сейчас есть ИГО, ИДСК, какие-то еще там, согласие обработки персональных данных. Уже сейчас заполняются?

0:31:05 **Наталья (Speaker B):** Нет, нет, нет. Сейчас, давай, я-то рассуждаю исключительно понятиями программы 1С. В программе в 1С заполнения этого нету.

0:31:16 **Speaker A:** Так, а как сейчас это реализовано?

0:31:18 **Наталья (Speaker B):** Подожди, оно же у нас в программе, ты не можешь открыть, и у тебя будет вот его соглашение, которое он подписал, и которое хранится... И это да.

0:31:28 **Speaker A:** Подписанного нет, потому что закон о верификации документов, тем более медицинских, он как бы еще не совершенен. Скана подписанного нет. Скана тоже нет, да. Предзаполненный документ без подписей, он есть.

0:31:42 **Наташа (Speaker D):** А мы не будем вводить электронную подпись? Это шаблон.

0:31:46 **Speaker A:** По закону нельзя. Единственная электронная подпись может быть, а для медицинских документов она квалифицированная, только на флеш-накопители, которые выданы тебе.

0:31:56 **Наташа (Speaker D):** Нет, я когда в Альфа входила на прием, там у них стоит планшет, и они не распечатывают мне бумагу, я там такая расписалась.

0:32:04 **Speaker A:** Это, по идее, еще незаконно. Это делают люди на свой страх и риск подписывать специальное доп. соглашение, потому что эта подпись является достоверной, но по сути...

0:32:11 **Наталья (Speaker B):** А вы про Макс анонсы смотрели?

0:32:17 **Наташа (Speaker D):** Нет.

0:32:18 **Наталья (Speaker B):** Что там можно верифицироваться через госуслуги и так далее. Там можно верифицироваться через госуслуги и его привязывают ко всем вот этим программам.

0:32:25 **Speaker A:** О, вот это, кстати, новое веяние какое-то, да.

0:32:28 **Наталья (Speaker B):** Я об этом даже не думал. Они хотят сделать так, чтобы через МАКС вот эти вот все как раз-таки лески и прочее могли передаваться пациенту напрямую. И все это бы хранилось в том числе и в программе, и в МАКСе. И это будет фактически аналогом простой лекарной подписи. В общем, зафиксировать, что именно делается, какие у нас действия со стороны пациента, какие данные он

Video_2026-04-28_160328_Индвиго (CRM 1 встреча)

должен подписать, что он должен заполнить. Вот это здесь нужно отметить. То есть без чего мы не сможем переходить дальше на следующие этапы.

0:33:21 **Speaker A:** Это должно быть разделено, потому что сейчас, посмотри, это и администратор, и работа с врачом в одной ячейке. Все окей, доставляем. Это пока общего достаточно, но это для заполнения.

0:33:34 **Наталья (Speaker B):** Я понимаю, но как бы картину интересовать надо, без чего это правильно. Тут уже админы вступают, они оформляют.

0:33:53 **Speaker A:** Врач.

0:33:54 **Наталья (Speaker B):** И тут уже отдел продаж.

0:34:01 **Speaker A:** Вот уже, видишь, на втором этапе идет. Врач передает назначение в отдел продаж.

0:34:07 **Наталья (Speaker B):** Ну, он передает, отдел продаж еще не принял.

0:34:11 **Speaker A:** Он принял. То есть врач с пациентом выходит из кабинета уже с картой, с назначениями и передается, знакомится с менеджером отдела продаж. Все, и начинается работа.

0:34:23 **Наталья (Speaker B):** Да, я тебя понял. И вот как раз это назначение он не должен... Он должен передать, и мы говорим... Предзаполнение врачом.

0:34:44 **Speaker A:** Заказы. Вообще мы стремимся и мечтаем о идеальной системе, когда врач уже, заполняя консультативный лист, уже сейчас есть функция, у нас Плесовская, по-моему, так работает, она сразу закидывает услуги. То есть она, по сути, заказ уже сразу... И нивелирована проблема того, что что-то не внесено. И по сути задача врача только довести пациента до менеджера отдела продаж, просто передать, познакомить и вот этот элемент доверия родить. И все.

0:35:21 **Наталья (Speaker B):** Я это понимаю, да, и предзаполнение заказа на основе вот этого консультативника, чтобы он оформлялся не только на бумажке в печатном виде, а был оформлен в электронном виде уже в заказе, мы сейчас эту часть тоже доделаем. Тут необходима сила воли и работа с врачами. Да, это понятно.

0:35:44 **Наташа (Speaker D):** У меня сразу тут вопрос по консультативным листам. Это тоже наболевшая проблема. Сможем ли мы это как-то учитывать в CRM? К Рине Валерьевне вопросов нет. Все, что он назначает, всегда соответствует плану лечения. Сейчас мы столкнулись с тем, что некоторые врачи, вот сегодня была ситуация с Поплевиной, она вывела пациента, назначила обследование. лечение в плане на 100 тысяч рублей, но при этом она говорит, это лечение не для пациента, это для меня напоминание, чтобы когда он пришел потом, я не забыла, что я тут написала.

0:36:19 **Speaker A:** Это, мне кажется, Наталья, вопрос не в спектре. Я понимаю. Вопрос чисто с главным врачом, чтобы он родил стандарты, которые врач должен выполнить. Не всегда.

0:36:35 **Наташа (Speaker D):** Кажется. Может быть, у них там можно просто сделать какую-то для них напоминалку, я не знаю, в 1С, куда они могут фиксировать, но не закидывать еще это в сделку.

0:36:46 **Speaker A:** Ну, 1С – это инструмент, который может быть просмотрен контролирующими органами и прочими. Тут лишних черновиков быть не может. И вообще нужно быть готовым, что с переходом на ИКИ и СССР любой консультативный лист, который заполнен, должен очень строго соответствовать стандартам Минздрава и прочего. То есть никаких там отклонений быть не должно.

0:37:09 **Наталья (Speaker B):** Да, все верно. Там строго по справочнику все наименования в соответствии к кодам.

0:37:20 **Наташа (Speaker D):** А исправления у них будут допустимы или нет? Еще раз. Исправление в консультативном листе. В рамках одних суток календарных.

0:37:30 **Наталья (Speaker B):** Там, когда рэм-то уже оформляется, этот электронный документ.

0:37:34 **Speaker A:** Это почти сразу улетает. Кому сутки, я не помню там. Ну, что-то очень быстро.

0:37:38 **Наталья (Speaker B):** Да, все верно. Там можно настроить онлайн режим, правки в него доступны. Это вообще.

0:37:45 **Наташа (Speaker D):** Ну, я правильно понимаю, что если врач дописывает что-то в консультатив... Ну, вот когда мы перейдем на вот эту систему от руки, мы ничего не добавляем, собственно, ручно.

0:37:54 **Speaker A:** Все, консультативник заполнен, все, больше ничего. И типа даже такого не будет, что откатить консультативный лист через неделю, что я что-то пропустил там, да заполнил. Значит, на основании этого должен быть новый консультативный лист до назначения, причем обоснованный.

Video_2026-04-28_160328_Индвиго (CRM 1 стреча)

0:38:17 **Speaker C:** Так, ну, отметили опять же.

0:38:29 **Speaker A:** Андрей, ты себе еще какие-то комментарии пишешь?

0:38:31 **Наташа (Speaker D):** Да, да, он пишет.

0:38:36 **Speaker A:** Так, ты закидывай их сюда сразу. Так, дальше D3.

0:38:46 **Наталья (Speaker B):** Например, я пример приведу.

0:39:08 **Speaker A:** Любой консультативный лист сейчас заканчивается тем, что на первичный прием пришел человек, познакомились в первый раз. Врач, как правило, говорит, пройти MPT пока острый период, трамплин или что-то, через неделю. Вот это может CRM подхватывать? Это будет сигналом к тому, что отдел продаж должен через 3 дня связаться и запланировать визит.

0:39:32 **Наталья (Speaker B):** Опять же, настроить и сделать так, чтобы она это делала, мы можем.

0:39:38 **Speaker C:** Вопрос, когда это будет выявлено.

0:39:40 **Наташа (Speaker D):** Хотя очень громко будет.

0:39:42 **Наталья (Speaker B):** Вопрос, как это именно будет выглядеть, насколько это будет, соответственно, применимо потом и используемо всеми пользователями?

0:39:53 **Наташа (Speaker D):** А вот сразу вот здесь на первичном приеме, после того, вот смотри, мы внесли услуги, да, у нас вышла стоимость. Сроки чего? Сроки оплаты, сроки прохождения. Здесь нужно указывать, например, я хочу видеть сумму выкупа, сумму отложенной сделки, я не знаю, что конкретно, это обследование, либо это физиопроцедуры, это вот куда, это здесь, либо это дальше.

6. Обсуждение этапов продаж и контроля оплаты пациентов

0:40:20 **Наталья (Speaker B):** Здесь же, наверное. Здесь же, да? Сроки прохождения может врач. Мы говорим о первичном приеме, о том, что врач назначает. Мы говорим о том, что врач говорит о том, когда это нужно пройти.

0:40:36 **Наташа (Speaker D):** А когда у нас это должно быть оплачено, это уже, наверное... Например, вот он вышел, мы внесли, например, курс лечения на 100 тысяч рублей, он сейчас внес 50. Я хочу, чтобы у меня эта сделка упала в частично оплаченные, я видела, что пациент должен, например, куратор с ним связаться через 5 дней. Ну, грубо говоря, ну так образно сейчас совсем, да? Либо что это полная оплата, пациент сейчас все оплатил, и он находится на стадии прохождения лечения.

0:41:07 **Наталья (Speaker B):** То есть, да, мы тогда следим уже. Да, это уже вот эта строчка. Первый контакт продаж. То есть, как он должен быть зафиксирован, какие там поля у него заполняются, и как он должен двигаться. Именно это уже формирование воронки самой.

0:41:23 **Наташа (Speaker D):** А здесь тогда что?

0:41:24 **Наталья (Speaker B):** Тут скорее вот как раз путь клиента. Путь клиента это не совсем воронка, она более расширенная, включает в себя много ветвлений, которые мы уже будем какие-то в слои воронки объединять.

0:41:44 **Speaker A:** Наташа, я 3 из тебя заполню. Я 3.

0:41:53 **Наташа (Speaker D):** Получить карту?

0:41:56 **Speaker A:** Нет, это шаблон, Наташа, это можно смело стирать, нужно понять, что после выхода от врача менеджер делает, потому что что-то может быть здесь для Андрея. Например, условно, мы с тобой уже зафиксировали какие-то возрасты, что-то еще и так далее. То есть менеджер, наверное, должен, во-первых, отработать возражения.

0:42:14 **Наташа (Speaker D):** Мы можем сделать так, что, смотри, Андрей, у нас то, что мы разрабатывали все совместно на тренинге с ИИ, когда присваивается возраст, определяется поколение. Там, да, бумеры, зумеры, либо миллениалы. Исходя от этого, там у них еще вылазят подсказки в виде скриптов, что... Либо критично, что нельзя произносить с этим человеком, либо наоборот, что можно. Такое можно куда-то впихнуть, либо нет?

0:42:40 **Наталья (Speaker B):** Еще раз, впихнуть такое можно. Тут вопрос в сроках, насколько это будет необходимо сделать сразу же. То есть мы не собираемся рисовать сейчас какой-то звездолет. Мы хотим сделать продукт, который на старте будет понятен и поменим, а дальше уже его можно будет обвешивать дополнительно. Эти обвесы мы сейчас можем предусмотреть действительно. Но вот это вот скриптование, помощь в заполнении и прочее, не думаю, что прямо на старте все это нужно сделать, потому что скриптуют, то есть автоматизация подвергает те вещи, которые уже работают и проверены в ручном режиме. Вот в ручном режиме заполняете где-то?

Video_2026-04-28_160328_Индвиго (CRM 1 встреча)

0:43:22 **Наташа (Speaker D):** Ну, это комментарии, а для того, чтобы увидеть комментарии, приходится залазить, открывать карту каждого пациента. А вот хотелось бы какие-то комментарии, либо знаешь, как, например, я заполняю, у меня вылезла там, например, бабушка 74, мы там на первом этапе определились, что иногородняя, я занесла всю там сделку, у меня получается длительное лечение, мне там, хоп, восклицательный знак какой-нибудь, важно, там, да, какие-то там, вот это, вот это, вот это нужно сделать.

0:43:46 **Наталя (Speaker B):** В обычном режиме как-то отрабатывается сейчас с кураторами? Есть какой-то условный, я не знаю, регламент, не регламент у них? То есть, что нужно в каком порядке говорить пациенту?

0:43:57 **Наташа (Speaker D):** Да, да, да.

0:43:59 **Наталя (Speaker B):** Где?

0:44:02 **Наташа (Speaker D):** Ну, это в 1С не где-то, ну, как это, ручная.

0:44:05 **Наталя (Speaker B):** В гугле, да. А где оно? На руках, в распечатанном виде, где-то в электронный документ есть?

0:44:11 **Наташа (Speaker D):** В электронный документ есть, ну, регламенты есть. Стандарты продаж.

0:44:17 **Наталя (Speaker B):** Тогда познакомь меня с ними.

0:44:19 **Наташа (Speaker D):** Хорошо.

0:44:21 **Speaker A:** Коллеги, у меня еще такой вопрос. Андрей смотрел, что с Наташей говорит о всяких...

0:44:30 **Наталя (Speaker B):** Смотрел какая как они реализуют сейчас на сто процентов не видел один единственный раз в первую неделю своего устройства на работу большинство вещей которые как бы происходят так очень обязательно дотреют этот провести какие-то элементы вот этих точек контакта они уже есть

0:44:51 **Speaker A:** Я сейчас понимаю, что ты сейчас говоришь про комментарии про бабулю, да, 74? Да, да, да. По сути, это и есть какая-то сегментация уже. То, что Андрей спрашивал у нас 10 минут назад. И познакомив сейчас с процессом работы еще раз более так неторопливо и вдумчиво Андрея, как мы уже... Андрей, мы ждем тебя в гости к нам сюда.

0:45:10 **Speaker C:** Так я-то с радостью давай как бы...

0:45:13 **Speaker A:** Планируйте сразу встречу, потому что, мне кажется, Андрей очень много вещей дорисует сам изнутри. Ну, поймет просто.

0:45:19 **Наташа (Speaker D):** Ну, потому что, да, он чуть-чуть послушает, и они еще свои боли какие-то расскажут.

0:45:23 **Speaker A:** Можно не послушать, можно, Наташа, я бы даже хотел, чтобы это ты сделала, либо Соля вместе. Показать, на что вы опираетесь, что вы заполняете, как ты их контролируешь. Андрей это увидит из твоей точки зрения, руководителя, из точки зрения менеджеров, то, что ты от них требуешь, как они это делают.

0:45:41 **Наталя (Speaker B):** В общем, в любом случае, что сейчас с ними делается, вот эти все регламенты можешь уже подготовить. Я могу тебе скинуть ссылку просто, да, либо как бы... Не хотелось бы хоть какой-то комментарий, то есть куда в этой ссылке, на какие поля и как смотреть. Описание такое сможешь подготовить, будет вообще здорово.

0:46:03 **Наташа (Speaker D):** Да это же там пипец писать сколько.

0:46:04 **Наталя (Speaker B):** Ну... Согласен. Давай поработаем вместе. Я тебе скажу, что у меня тут тоже много чего надо будет написать. Так. Тоже от Натали. Понятно. В каких отчетах? Вот, супер. Так, Наташ, срок? Не знаю.

0:46:29 **Speaker A:** Не знаю. Я хотел бы, чтобы вообще вот этот этап...

0:46:34 **Наталя (Speaker B):** Постараться заполнить предварительно все таки пишем что наташ это минут к тридцатому числу 30 апреля данные предоставишь конкретно какие вот просто думаю сколько терек

0:46:59 **Наташа (Speaker D):** Там их просто много. На данном этапе что для тебя важно? Вот в первичном приеме. Этапное соблюдение переговоров или как? Или вот что? Просто у них, например, есть регламент распределения сделок, пациентов, взаимодействия с врачами, планирование, как они должны... Наташа, бегите с Андреем в встречу, когда вы покажете, когда вы сделаете работу, и прям там садитесь, и ты покажешь.

0:47:27 **Speaker A:** Андрей, у меня вот есть этот регламент. Коротко, это вот это, вот это, вот это. Андрей говорит, так, нахрен, следующее. Ты говоришь, ага, регламент отработки возражений. Такой Андрей говорит, ага, отлично, мы сможем оттуда вот это, возможно, родить. Ну, расскажи мне как раз. Вот так по каждому документу прошли. А еще ты отвечаешь, Андрей, у меня нет вот этого. Будет вот это еще.

Video_2026-04-28_160328_Индвиго (CRM 1 встреча)

0:47:49 **Наталья (Speaker B):** Я думаю, вот 30 апреля мы как раз это и сделаем. Я подъеду к вам. Ты будешь там на месте. Какое время обозначь просто.

0:48:03 **Speaker C:** А что это? Что с 8 до 8?

0:48:06 **Наташа (Speaker D):** Это кто сказал, что с 8 до 8? Я не говорю, что с 8 до 8. Это так, с 9 до 4, до 5. Я, по-моему, 30-го я не помню. Сейчас я посмотрю.

0:48:20 **Speaker A:** Задача поставлена 30-го.

0:48:22 **Наташа (Speaker D):** У меня я буду, мне в больницу надо сходить, мне надо посмотреть, во сколько я записана на прием. Ну вот, я посмотрю прием, во сколько я записана. А в 11 утра у меня прием у врача. Ну, с 12 я буду здесь. Ну, как бы я буду с 9 до 10.30, потом с 12.

0:48:41 **Наталья (Speaker B):** Так, хорошо, давай тогда отметим. С 12.00.

0:48:47 **Speaker A:** Так, дальше двигаемся или как?

0:48:53 **Наталья (Speaker B):** До 17.00. А вообще этот блок мы его постараемся сделать.

0:49:10 **Наташа (Speaker D):** Ну вот, работа с возражениями, вот здесь и потребуется.

0:49:20 **Speaker A:** Коллеги, вы на какой ячейке?

0:49:27 **Наташа (Speaker D):** Четвертая строчка. Первый контакт продаж.

0:49:32 **Наталья (Speaker B):** Видно?

0:49:34 **Speaker A:** Видно, но я в этом чате, чтобы комментарии сразу записать. Твой экран маленький очень.

0:49:39 **Наталья (Speaker B):** Мой экран очень маленький.

0:49:41 **Speaker A:** Я специально его уменьшил, чтобы смотреть на документы.

0:49:56 **Наталья (Speaker B):** Это тот момент, когда врач говорит, ну, оставляю вас вдвоем, пошел.

0:50:04 **Наташа (Speaker D):** И вот здесь, да, там... Здесь уже пойдет от сегментации, мне кажется, как раз-таки уже не по пациентам, а внутри. Стопроцентная оплата, частичная оплата, подумать. Либо он... Вот опять же, частичная оплата, я тоже хочу видеть разветвление. Это просто обследование, либо это часть курса.

0:50:24 **Наталья (Speaker B):** Ну, то есть вот такие моменты. Это только... Это сюда, да? Сегментация и прочая информация. Список от Натальи. Тут мне вот это не совсем понятно, Вадим.

0:51:05 **Наташа (Speaker D):** Мне тоже, да. Тут, наверное, просто диалог, я не знаю, потому что мы только разговариваем.

0:51:10 **Speaker A:** Что-что-что? Это который? С4? В4, ну да. О, С4. Не, Наташ, я бы хотел видеть здесь расширенный список. Помнишь, как у нас этапы были? Этапность.

0:51:22 **Наташа (Speaker D):** Подожди, нет, мы говорим про то, что первый контакт, в моем понимании, это диалог. То есть мы в процессе диалога. И вот здесь будет принято решение дальше, что происходит. Тут еще не звонок, тут еще диалог.

0:51:38 **Speaker A:** Они еще общаются, да, все, согласен, я уже начал фантазировать дальше. Я не знаю тогда.

0:51:44 **Наташа (Speaker D):** Сейчас, минуточку. Здесь просто, наверное, стадия переговоров, я не знаю, что сюда написать. Надо подумать.

0:52:01 **Speaker A:** Тут просто продажа должна идти, выявление потребности и вот это вот все по продажам. А, возражения дальше идут.

0:52:13 **Наташа (Speaker D):** Да, да, да, возражения дальше. Здесь презентация, наверное, я не знаю.

0:52:16 **Speaker A:** Да, да. Да, презентация, выявление потребностей вообще у человека.

0:52:24 **Наталья (Speaker B):** Здравствуйте, звонили. Это как бы точка контакта отдела продаж? Да. То есть что мы здесь зафиксировать хотим?

0:52:32 **Speaker A:** Ну смотри, может быть, я здесь, что это подразумевается? Это идея, когда отдел продаж работает в этом своем интерфейсе, он же должен зафиксировать. вот эта сегментация, о которой Наташа говорила по теплоте клиента. У нас сейчас есть сегментация ABC просто. А готов полностью купить, Б сомневается, но в целом готов. Цель вообще не готов, сомневается, не будет вообще в последнюю очередь его трогать. На этом этапе можно сегментация тоже продлиться после отработки возражений. А вот то, о чем говорит Наташа про выкуп, это уже следующее, это В5. То есть она уже видит общий объем назначения, например, на 100 тысяч рублей, что в

Video_2026-04-28_160328_Индвиго (CRM 1 встреча)

рамках переговоров договорились о том, что пациент проходит первый этап, на 40 тысяч рублей проходит диагностику и обезболивание условно. Все, и Наташа уже тут получает информацию о том, что клиент не выкупил полный курс, значит, с ним должны быть такие-то точки контакта. Наташа, правильно я говорю?

0:53:40 **Наташа (Speaker D):** Да-да-да. А у нас будет возможность QR-код онлайн оплаты?

0:53:51 **Наталя (Speaker B):** Было бы очень здорово.

0:53:54 **Speaker A:** У кого?

0:53:54 **Наташа (Speaker D):** У отдела продаж? Ага.

0:53:55 **Наталя (Speaker B):** А у вас сейчас касса без QR-кода работает?

0:53:59 **Наташа (Speaker D):** Нет, я имею в виду то, что мы можем переслать какой-то QR-код нашему иногороднему пациенту. Он на первый звонит и говорит, я приеду к вам через неделю, запланируйте мне мое лечение. Мы ему скидываем на телефон QR-код, он оплачивает, к нам поступает оплата, мы все планируем. Такого не будет?

0:54:13 **Наталя (Speaker B):** Онлайн оплата, Андрей, она имеет в виду.

0:54:17 **Speaker A:** Сделать можем, предусмотреть такую.

0:54:18 **Наташа (Speaker D):** Потому что очень было бы нам это очень нужно. Или то же самое, например, пациент оплатил первую половину, мы с ним связываемся, говорим, готовы, мы сразу займем вам окошки, сейчас пришлю QR-код и получаем оплату.

0:54:41 **Наталя (Speaker B):** Задача получить оплату. Задача менеджера. Презентовать комплекс.

0:54:44 **Speaker A:** Андрей, ты знаешь наши отношения к оплате, к единовременной оплате? Почему мы так делаем? Нет, не знаю. Смотри, в общем-то есть два пути. Первое – это получать оплату за каждую услугу. Сделал, оплатил, выполнил одну процедуру УВТ. Пришел через два дня, снова оплатил. Но мы сторонники именно комплексного подхода, и нам это, прежде всего, для бизнес-процесса почему важно? Потому что мы планируем отвлечение длительное, сразу же, целиком. Физиокабинет, массаж и так далее. Ввиду того, что у нас сейчас порядка 150-200 пациентов в день в центре, в КАРе приходят, и в остальные тоже загрузка большая. Вот эта единовременная принятая оплата за комплекс, либо за половину хотя бы, нам планировать его услуги, не боясь, что он не придет, сорвется и так далее. Потому что если мы начинаем получать оплату поштучно, то клиенты, получая облегчение после 3-5 процедур, они просто забивают. Получается, что ответственность за результат лечения переходит просто к клиенту, и он просто это сам регулирует, ходя по разово и забивая. Когда мы получаем на разово, то, например, мы вот этот комплекс продаем разносторонний, и это как наше материальное подтверждение того, что у нужно целый курс этот пройти.

0:56:13 **Speaker A:** Мы платили единоразово и полностью планируем. Означает, что его ответственность перед нами и перед собой, потому что он платил весь этот комплекс, гораздо выше. И конвертация, доходимость до конца этого курса тоже значительно выше. И для бизнеса это тоже очень хорошо, потому что деньги мы получаем единоразово.

0:56:31 **Наталя (Speaker B):** Понятно, но не 100% все-таки предоплатно.

0:56:35 **Speaker A:** Конечно, да. Наташа тоже, тем более в текущей комиссии. Они стараются это отрабатывать,

0:56:43 **Наталя (Speaker B):** Тут тоже надо будет зафиксировать способы оплаты и соответственно на какую стадию заломки должен будет переходить и продолжить.

0:56:54 **Наташа (Speaker D):** Да, потому что сейчас у меня самая загвоздка в том, что я не могу контролировать вот эту этапность

0:57:00 **Speaker A:** Ну, короче, потом приедешь как раз, когда я тебе... Наташа, ты сейчас не видишь, какой у тебя объем денег еще недополучен.

0:57:06 **Наташа (Speaker D):** Ну, да, ну вот, я про это говорю. Например, было бы круто, вот я то, что показывала, пока тебя ждали, ну, CRM-ка там, да, например, висят первичные пациенты, потом частично оплаченные, я вижу, какая сумма еще не оплачена, понял, когда? Ну, то есть сколько оплачено... Которую нужно дополучить, значит, и забить через менеджера. Здесь, например, дальше у меня идут полностью оплаченные в процессе прохождения, там, завершили, ну, то есть вот такое. Ну, вот,

0:57:30 **Наталя (Speaker B):** Я понимаю, о чем ты говоришь. Санктаж, мне нужно понимать, что ты с этим будешь делать.

0:57:41 **Наташа (Speaker D):** Так что, во-первых, дальше углубляться вовнутрь. Я буду видеть в разрезе, во-первых, у кого сколько, в какой стадии, когда последний контакт. Если просрочка, то сколько? Один, два, три, семь дней. Для этого нужно будет разработать, ну как у нас стандарты течения, например. Я за то, что если пациент выкупил, например, всего лишь 50% простого, Он выкупил, мы запланировали, чтобы уже звоночек выскакивал за две процедуры до окончания этого.

Video_2026-04-28_160328_Индвиг (CRM 1 встреча)

0:58:13 **Speaker A:** Я вот это и жду. То есть ты должна, мне кажется, Андрею дать действие. То есть, например, ты видишь, что у тебя на сегодняшний день 500 тысяч неоплаченных процедур. Ты должна видеть в разрезе менеджеров. И в развитии каких сделок они этого не сделают. На основании этого ты можешь ставить сразу задачи. Диана, три задачи, у тебя три клиента подвисло, все, их сегодня обзвонить. Ты им поставил, то есть функционал задач должен с этого как-то работать.

0:58:37 **Speaker C:** Плюс еще, чтобы внутри... Все, понесло.

0:58:42 **Наталья (Speaker B):** Да, потому что мне сейчас уже тоже надо убегать по проектированию, встречу с ВК делать. Давайте тогда в четверг мы с тобой встречаемся после 12, проговариваем еще раз. До того времени я поговорю с маркетингом. С маркетингом?

0:59:02 **Speaker A:** С маркетингом. Так, подожди, у нас в четверг в этот вы встречаетесь. Да, да. А я Андрея теперь не заполню по маркетингу до 30-го, до следующего.

0:59:12 **Наталья (Speaker B):** До 7-го-то да, но вот когда я смогу получить эти данные, соответственно, маркетинг, чтобы понимал эти данные, то есть я жду их от тебя, правильно?

0:59:22 **Speaker A:** Я передам это Владу Гусельникову, заполнять это будет Владу Гусельникову под моим контролем. Да, но я до этого 4G тебе не дам. Я передам их Владу, как он выйдет на следующей неделе, он этим займется.

0:59:33 **Наталья (Speaker B):** Хорошо, хорошо. Просто чтобы понимали то, что ты им передашь, мне как бы встретиться и... Я объясню.

0:59:38 **Speaker A:** А, ну не знаю, Андрей, как скажешь, ты будешь с ними встречаться или все вместе с вами. Я бы сейчас из вопроса CRM максимально не выключался, потому что я понимаю, что если я где-то выпаду, я еще сам не до конца понимаю, что мы получим в итоге-то. Хотя бы до этого момента быть с вами очень сложно.

0:59:54 **Наталья (Speaker B):** Ладно, все, принято. Сейчас я тогда уже удаляюсь. Всем хорошего дня.

1:00:00 **Speaker C:** Пока.